

3 революции в психиатрии, которые изменили ее навсегда

Medicine Live · 1 сен 2018

1. Создание первой психиатрической больницы

Еще в 18 веке не было психиатрических больниц – были бедламы. Бедлам – это заведение, куда привозили психически больных людей в самом тяжелом состоянии, когда родственники уже не могли терпеть их дома или это было опасно. По сути это были приюты, которые содержались за счет приглашения зрителей за деньги. Взрослые и дети ходили в бедламы, как в театр или зоопарк, и наблюдали за странным и пугающим поведением одержимых и помешанных. Психически больных держали на цепях. Они выли, кричали, что-то бормотали, корчили рожи, попрошайничали, совершали непонятные движения.

Несложно догадаться, что представление о психических болезнях в то время сложилось очень яркое, и до сих пор будоражит любопытных.

В 1793 году в один парижский приют был назначен молодой врач Филипп Пинель, который впервые решил снять с больных цепи. Его представление о психических болезнях было несколько иным, чем у других его коллег. Он первый сказал о том, что помешанные – это больные люди, и им нужна помощь. Решение снять цепи с больных вызвало большой резонанс в городе. Сюда приходил даже начальник парижской коммуны проверить, не скрываются здесь под видом больных враги революции. Но когда стало понятно, что Пинель тверд в своем решении, все попытки избежать странного новшества оставили.

Все служители бедлама Бисетр сбежали: они боялись, что помешанные растерзают их, как только получат свободу. Конечно же ничего подобного не произошло. В Бисетре остался Пинель и его друг, которые стали лечить психически больных, в меру возможностей того времени. Но самое важное в новом подходе было не в методах лечения, а в отношении к пациентам. Внимание к простым человеческим потребностям и забота оказывали благотворное действие, лечили душу душевнобольных.

выздоровление – бедламы стали перепрофилировать в психиатрические лечебницы по всей Европе. Филипп Пинель преподавал психиатрию в медицинском университете до 1822 года, и даже был врачом-консультантом Наполеона.

Но даже сейчас существуют заведения для психически больных, подобные бедламам 18 века. Приюты Индонезии переполнены несчастными, которые живут в клетке на цепи.

2. Открытие психиатрических амбулаторий: свободное посещение больницы
Еще один человек, который смог изменить жестокую систему – Клиффорд Бирс. В начале 20 века он в течении трех лет вынужден был проходить лечение в одной из психиатрических больниц США. Условия, в которых находились пациенты в больнице, привели его к решению кардинально изменить организацию психиатрической помощи.

В 1909 году появилась MentalHealthAmerica – первая общественная организация психически больных, которая до сих пор ведет активную работу. Основателем ее стал Клиффорд Бирс. Результатом деятельности Mental Health America стало открытие психиатрических амбулаторий, куда пациенты могли приходить днем, на несколько часов, а потом возвращаться домой.

Такой подход был очень непривычен для психиатрии, но он позволял оказывать адекватную психиатрическую помощь не только при тяжелых психозах (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз), но и при невротических расстройствах: страхах, фобиях, навязчивостях. Также это позволяло наблюдать за больными в период ремиссии, и помогать им при необходимости еще до того, как снова наступит психоз.

Эта перемена снова заставила психиатров задуматься о природе психических заболеваний и стимулировала их к поиску новых методов лечения.

Тем не менее в большой психиатрии все еще оставались жесткие меры содержания больных, так как бороться с возбуждением и агрессивным поведением в период острой фазы психоза было нечем. Решетки на окнах, тяжелая неподъемная мебель, железные двери, смирительные рубашки: все это защищало и персонал больниц, и самих больных. Полностью воплотить идеалы Пинеля в психиатрии не получалось даже в 20 веке.

В 1952 году Жан Делэй и Пьер Деникер создали препарат хлорпромазин, который был предназначен для успокоения возбужденных больных. Это перевернуло весь подход к лечению в психиатрии. Теперь можно было не ограждать от пациентов железными засовами, и лечение стало более гуманным, а у больных появилась перспектива возвращаться домой после тяжелого периода. До этого психиатры практиковали лоботомию, электросудорожную терапию, инсулиновые комы, заражение трехдневной малярией (высокая температура снижала смертность от прогрессивных параличей). Все эти методы были в какой-то мере эффективны, и даже снижали смертность в психиатрии. Но процесс лечения больше походил на пытки. Теперь у психиатров было лекарство, которое можно было вводить больным регулярно, купировать возбуждение и помогать пациентам вписаться в обычную жизнь даже после тяжелого психоза.

Недостатком первых нейролептиков стало их разрушительное действие на личность и физическое здоровье больного. При длительном приеме аминазина и галоперидола развивается нейролептический синдром. Но все же это было лучше, чем то, что получали больные до этого.

Аминазин (хлорпромазин) стал основой для создания более совершенных препаратов, которые теперь могут применяться длительно, не вызывая тяжелых изменений личности

Теперь психиатрия располагает современными лекарствами, применение которых можно совмещать с привычным образом жизни.

Количество психических больных с начала 20 века за сто лет выросло в 40 раз. Но это не значит, что стало больше нездоровых людей. Это свидетельство того, что психиатрия теперь может помогать даже при тех расстройствах, которые раньше не принимались во внимание.



2693 просмотра · 69 поделились

